

INDICADO POR: Dr. Paulo

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

MAURICIO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR

IDADE: 36 PESO: 104 ALTURA: 1,74 PROFISSÃO: TapeiroSINTOMAS: Dorata que não apresenta, indicação do cardiologista de arritmia.QUEIXAS: Arritmia e sono fragmentadoMEDICAMENTOS: Relaxante (metoprolol 25mg)MÉDICO: Dr. Jose Carlos de Almeida (Cardio)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 4x semanaHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 21-22hHORA QUE DORME: 23-0h HORA QUE ACORDA: 7-8h

COCHILO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S () N (X) EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () N X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: nao MALLAMPATI: II IAH: 26 l/h SPO2: 96%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: investigando arritmia cardiaca.CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA adenoide.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

14/06/25 Ambulatório Loracão marc V30 i (M)
Natacha24/06/25 P=8,6 cmH₂O (percentil) + fixo pressãoIAH=5,2 e/hmdc uso: 4h 14'fuq: 19,9 l/mNatacha08/07/25 P=7,6 cmH₂O↓ P=6,6 cmH₂OIAH=3,1 e/hmdc uso: 3h 27'fuq: 20 l/mNatacha

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Mauricio Teodoro de Almeida Junior
EXAME nº: 4830
SOLICITADO POR: Dra. Denise Vaz Garcia
DATA: 11/02/2021
IDADE: 32 anos

CPAP

Comentários:

Exame iniciado às 22h42min e concluído às 06h06min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o estágio REM, de 91 minutos. O tempo total de sono foi de 343 minutos (05h43min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 77,8%. A distribuição do sono mostrou 17,8% de estágio 1, 50,4% de estágio 2, 11,1% de estágio 3 e 20,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 88,5 minutos em vigília, ocorreram 152 microdespertares (índice: 26,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 26,1/hora, sendo 7,4 apneia/hora e 18,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 26,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 76%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (26,1/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (26,1/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 42; máxima: 63 bpm.

Sem ronco.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (91 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 77,8%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 26,6/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (17,8%; normal: 5%) e a redução do estágio 3 (11,1%; normal: 15-16%). As porcentagens dos estágios 2 (50,4%; normal: 45-55%) e REM (20,7%; normal: 20%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730